

	IMPRESIÓN DE HISTORIA CLÍNICA PSICOLOGÍA	
	Historia # 00004	Fecha De Impresión: 25-07-2025 18:36:37

Datos Personales							
Nombre:	CARLOS RAUL ROMERO LOZANO	Sexo Biológ.:	H	F. Nacimiento:	2015-10-26	Edad	9 Años, 8 Meses, Y 30 Días
Identificación:	TI - 1235242423	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	MARY.GISELYCH1@GMAIL.COM - 1235242423			Dirección:	MZ 23 BLOQUE LOS GIRASOLES		
Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana	
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		MARY GISELY LOZANO - Parentesco (madre) - Teléfono (3217348546)					

Apertura psicología del 2025-05-28 16:39:31: 9 años, 8 meses, y 30 días

DATOS GENERALES
Remisión Particular
DX principal F900 - PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION DX Relacionado 1 F845 - SINDROME DE ASPERGER
Código de consulta 890308 - CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR PSICOLOGIA
Motivo de Consulta El paciente menor de edad con 8 años ingresa a consulta acompañado de la madre la señora MARY GISELY LOZANO y refiere "se porta mal, hace muchos berrinches, no hace caso a veces, no le gusta recoger los juguetes, se enoja feo y grita" "me manotea y frunce el ceño".
Enfermedad Actual Acude debido a la presentación de sintomatología caracterizada por conductas disruptivas y desadaptativas en el contexto familiar y escolar, inflexibilidad ante los cambios, atención dispersa, pensamiento rígido, rutinas en sus actividades diarias, baja tolerancia a la frustración, fijación en temas específicos, dificultades en la reciprocidad emocional, selectividad en los alimentos y con las personas, con cuadro de evolución desde hace 3 años aproximadamente. Los síntomas se han agudizado hace 6 meses presentando irritabilidad frecuente.

ANTECEDENTES	
Médicos Personales	
Quirúrgico No Refiere	Tóxicos No Refiere
Traumáticos Ninguno	Medicación PSIQUIATRÍA Risperidona Gotas 1mg, Metilfenidato 10 Mg (sin Administración)
Paraclínicos Ecografía Abdominal, Resonancia Cerebral Con Resultados Normales.	Hospitalizaciones No Refiere
Patología No Refiere	

ANTECEDENTES	
Prenatales	
Edad De La Madre En El Embarazo 31	Enfermedades De La Madre No
Único Embarazo 1mer	El Embarazo Fue Controlado Por Atención Médica Si
Uso De Planificación En El Momento Del Embarazo Si	Estado De La Madre Durante El Embarazo Cuadros Depresivos, Ansiosos, Irritación.

ANTECEDENTES
Natales

Tipo De Nacimiento Cesarea	Causa De La Cesárea Cordón Enredado Doble Y Encajado
Uso De Maniobras De Reanimación No	Peso Al Nacer 2900
Talla Al Nacer 50 Cc	Lianto Al Nacer Si

ANTECEDENTES

Posnatales

Hospitalizaciones Recién Nacido No Refiere	Desarrollo Psicomotor No Refiere
--	--

ANTECEDENTES

Desarrollo Psicomotor

Control Cefálico 2M	Rolado 3M
Sedente Solo 6M	Gateo 6M
Bípodo Sin Ayuda 9M	Marcha 10M
Lenguaje Verbal 10M	Lenguaje Verbal Fluido 5 AÑOS

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión Abuela Materna	Ansiedad Abuela Materna
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos Cancer	Otros No Refiere

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa Actualmente cursa cuarto grado en la escuela Leonidas Acuña sede hogar del niño, en cuanto el rendimiento escolar le va muy bien aunque en los últimos meses no quiere escribir y se distrae fácilmente. En cuanto a preferencias en las materias se inclina más por las Ciencias naturales, arte, educación física, inglés, a veces no se inclina por las matemáticas.
Historia laboral No refiere.
Historia familiar Paciente actualmente vive con la mamá la señora Marygisely y el padrastro el señor Juan David Martínez con 42 años, integración social y adherencia en las relaciones interpersonales de su interés, adecuado nivel de conciencia, basada en la entrevista psicológica la relación familiar se encuentra en procesos de dialogo para mejorar la comunicación y establecer acuerdos.
Historia social Se adapta fácilmente en ambientes que le agradan y manifiesta las emociones a veces de manera apropiada y otras veces de manera inapropiada.
Historia socio-afectiva Presentó cambios emocionales y conductuales desde los 2 años de edad, agudizándose hace 2 años, se muestra predispuesto, irritado, fluidez verbal fluido, con conductas disruptivas, hiperactividad, momentos de euforia y emociones positivas.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica Intervención y control por Psiquiatría con Dx F900 Perturbación de la actividad y de la atención F913 Trastorno opositor desafiante, medicando con Risperidona gotas 1mg, Metilfenidato 10 mg.
--

Intervención neurológica

Intervención y control con Neuropediatría con Dx F900 Perturbación de la actividad y de la atención, F928 Otros trastornos mixtos de la conducta y de las emociones, F808 Otros trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje.

Intervención neuropsicológica

Intervención por Neuropsicología con Dx F84.5 Síndrome de asperger (principal), F900 Perturbación de la actividad y de la atención (comorbilidad), CIT de 116 capacidad general intelectual media alta, con necesidad de apoyo, con aplicación de prueba el 22 de abril de 2023 quien refiere en informe “según la aplicación de pruebas y observación clínica se obtiene un perfil de paciente con discapacidad intelectual moderada, perfil de autismo grado 1 o asperger, con alteración en las habilidades escolares, vida social y en familia, estableciendo los siguientes signos y síntomas: ecolalia mínima, fuga de ideas, dificultades en la comprensión, análisis y razonamiento, madurez muy por debajo de lo esperado, agitación motora, distractibilidad, le cuesta seguir comandos e instrucciones, poco esfuerzo cognitivo, patrón de comportamiento restringido y repetitivo, problemas en la adaptación y para aceptar los cambios, fracaso en la intención comunicativa e interacción social, hiperreactividad, disgregación o pensamiento incoherente, afecto insuficiente, emetropías motoras, hiperactivo”. Dr. Jainer Guzman.

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

El paciente menor de edad con 8 años ingresa a consulta acompañado de la mamá la señora Mary Gisely Lozano, se observa sonreído en toda la entrevista, con buen saludo, alerta, lenguaje expresivo verbal fluido, contacto visual intermitente, atención dispersa, participativo en opinión, consciente de los episodios vividos manifestados por la mamá y receptivo ante actividad y preguntas realizadas en la entrevista psicológica. El paciente es de piel blanca, ojos expresivos, cejas delgadas, nariz fileña, labios delgados, contextura delgada y estatura acorde a su edad, cabello castaño liso.

Ciclos del Sueño

Conservados.

Apetito

Selectivo con algunos alimentos.

Actividades de Autocuidado

Las realiza con instigación verbal.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):

F900 - PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION

Impresión Diagnóstica Relacionada 1

F845 - SINDROME DE ASPERGER

Establecido por primera vez

No

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

Favorecer el desarrollo integral del niño mediante la orientación a padres, el fortalecimiento de habilidades sociales, la aplicación de técnicas ABA y la estimulación cognitiva para mejorar la conducta, la comunicación y el desempeño académico.

Objetivos Específicos

- Sensibilizar a los padres acerca de las alteraciones presentadas en el niño y entregar pautas de manejo en la conducta y comunicación asertiva en el hogar para promover el avance.
- Entrenamiento en habilidades sociales y comunicación asertiva, para favorecer el manejo frente a la frustración.
- Aplicar técnica ABA para extinguir las conductas disruptivas y enseñar conductas socialmente aceptables.
- Favorecer los procesos cognitivos básicos y superiores a través de actividades dinámicas que fomentan el aprendizaje, para mejorar el rendimiento académico.
- Fortalecer las conductas adaptativas conservadas, para mejorar la calidad de vida.

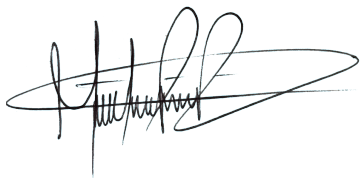
Sugerencias e Interconsultas

No refiero.

Observaciones y Recomendaciones

REALIZAR EL PROCESO DE INCLUSION EDUCATIVA ADECUANDO Y ADAPTANDO EL CURRÍCULO ESCOLAR AL NIÑO:

- Implementar por parte de la Institución Educativa el Plan Individual de Ajustes Razonables – PIAR (Subsección 3 Esquema de atención educativa – ARTÍCULO 2.3.3.5.2.3.1. Gestión educativa y gestión escolar), con el objetivo de favorecer el aprendizaje significativo y la motivación en el niño. Para lograr lo antes dicho es necesario aplicar estrategias de enseñanza que permitan el debido ajuste de logros y competencias según el nivel en el que se encuentra actualmente de acuerdo a sus capacidades y no las del grupo exclusivamente. Se sugiere el establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo en el transcurso del grado escolar que se encuentre en curso.
- Siempre dar un trato digno y con respeto al niño.
- Aplicar refuerzo positivo con elogio verbal en aquellas conductas adaptativas y positivas que emita.
- Sentarse cerca del docente (si el alumno es más alto que los demás compañeros, su sugiere sentarlo en un lado de las filas de adelante para evitar obstruir la vista de los demás y dar cumplimiento a la inclusión escolar).
- Permitale realizar pausas activas cuando presente la conducta de distracción atencional, no se tome el comportamiento personal es algo que el niño no puede evitar, lo cual se logra superar poniendo en prácticas los valores de paciencia y amor.



DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542
Mag. TP3G - VIU



PRASCA
CENTER